

عمل طموح ومنظم يغطي مساحة واسعة من التطبيقات الإكلينيكية في سبعة فصول، باختيار دقيق للموضوعات ومراجع مرجعية موثقة توثيقاً صحيحاً. الملاحظات التالية قائمة تجهيز للطبعة الأولى — كلها قابلة للتنفيذ دون إعادة بناء للكتاب.

أولويات المراجعة

#	الملاحظة	المقترح
1	الفصل الثالث — أقسام بعناوين بلا نص 22 عنواناً فرعياً (مؤشرات HIL، تقسيم شرائح WSI، تقييم IHC، نخاع العظم، الميكروبيولوجي، التحقق التحليلي والسريري) ظهرت في النسخة الحالية بلا متن.	استكمال متن الأقسام. خمسة أسئلة في بنك الفصل تختبر هذه الأقسام تحديداً، فيتعذر على الطالب الإجابة عنها من النص الحالي.
2	توزيع الإجابات في بنك الأسئلة الاختبار (B) هو الإجابة الصحيحة في 81% من الأسئلة الـ 135 (يصل إلى 24 من 25 في الفصل السابع)، والاختبار (D) لم يرد صحيحاً في خمسة بنوك من ستة.	إعادة توزيع مواضيع الإجابات بنسبة مقاربة (25% لكل اختبار)، لمنع تحصيل درجة مرتفعة بالتخمين دون قراءة المتن.
3	ست نقاط علمية تحتاج تحديثاً تفصيلها في الملحق المرفق.	• Critical View of Safety: إبراز المعايير الثلاثة، مع الإشارة إلى أن القناة الصفراوية المشتركة لا تُشَرَّح في هذا الإجراء. • Delta check: تلوث خطوريد يؤدي إلى انخفاض الكرياتينين بالتخفيف لا ارتفاعه. • ICG: إفرازه كبدي صفراوي؛ إظهار الحاليين يحتاج عاملاً آخر. • نسبة الـ $\geq 20\%$ blast: تحديثها وفق تصنيف WHO الطبعة الخامسة (2022). • نواة الاحتشاء الدماغي: حد الـ 30% يخص rCBF لا CBV (ورد في ستة مواضع). • العرشة الفسيولوجية: 8-12 هرتز.
4	قسم تعليمي مقترح: قراءة ادعاءات الأداء المصطلحات الأساسية لتقييم النماذج غير معروفة حالياً في المتن.	قسم تمهيدي (~900 كلمة): الحساسية والنوعية، منحنى ROC، سبب تضليل AUROC في المسح الميكرو، اعتماد PPV على معدل الانتشار، ومعامل Dice. أعلى الإضافات عائداً على القيمة التعليمية.
5	ربط المراجع بالمتن وتحديثها قائمة المراجع (23 مرجعاً) غير مرتبطة برقم استشهاد داخل النص، وأحدثها من عام 2023.	إضافة أرقام استشهاد داخلية للأرقام والادعاءات التنظيمية والتجارب المذكورة بالاسم، وتوسيع القائمة إلى ~200 مرجع تشمل إصدارات 2024-2026 ومعايير التقارير (TRIPOD+AI، CONSORT-AI، DECIDE-AI).
6	الإطار التنظيمي الأوروبي الفصل السابع يغطي مسارات الـ FDA بشكل جيد، دون تناول الإطار الأوروبي.	إضافة قسم عن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (2024/1689) ولائحة الأجهزة الطبية (MDR)، وتحديث فقرة الـ PCCP وفق التوجيه النهائي الصادر في ديسمبر 2024.

ملاحظة تستحق التنويه: جرى التحقق من المراجع الـ 23 جميعاً — الأسماء والمجلات والسنوات وأرقام المجلدات والصفحات — وثبتت صحتها بالكامل دون استثناء؛ نتيجة غير شائعة وتُحسب للمخطوطة.

الفصل السادس والقسم 7.4 (التحيز الخوارزمي وعدالة الرعاية) من أفضل ما في الكتاب صياغةً وتدرجاً تعليمياً، ويصلحان نموذجاً لضبط باقي الفصول عليه. ويُقترح توحيد الجمهور المستهدف على الغلاف ليكون طلاب سنوات الامتياز والنواب، بما يناسب عمق الفصول 2 و 4 و 5.

مراجعة أكاديمية مُعدّة بناءً على مصفوفة التقييم المرفقة بالمشروع · التفاصيل الكاملة بأرقام الأسطر في الملحق.